Caisse nationale

Fiche technique de l'indicateur
Catégorie : **Dépistage**
Trigramme : **DIA**
Version : **1.2**

I. Description

Parmi les personnes de 45 ans et plus atteintes de maladie cardiovasculaire ou associée, l'indicateur est validé pour celles ayant bénéficié d'un dépistage biologique du diabète par un dosage de la glycémie à jeun depuis 3 ans ou moins.

Les personnes ayant déjà un diabète connu sont exclues de l'indicateur.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les personnes de 45 ans et plus atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou associée […]* » :

- Age ≥ 45 ans
  ET
- ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'un des items suivants :
  - ALD 1 – Accident vasculaire cérébral invalidant
  - ALD 3 – Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
  - ALD 5 – Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires congénitales graves
  - ALD 12 – Hypertension artérielle sévère
  - ALD 13 – Maladie coronaire
  - ALD 19 – Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique

2. Critères d'exclusion

« *Les personnes ayant déjà un diabète connu […]* » :

- ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'item suivant :
  - ALD 8 – Diabète de type 1 et diabète de type 2

  OU
- Délivrance de médicaments antidiabétiques (classe ATC = « **A10**** ») :
  - SOIT :
    - Au moins 3 délivrances dans les 12 derniers mois
      OU
    - Au moins 2 délivrances dans les 12 derniers mois, dont au moins un grand conditionnement
  - SAUF les molécules suivantes :
    - Médicaments agonistes du GLP-1 (classe ATC = « **A10BJ** »)
    - Médicaments inhibiteurs du SGLT2 (classe ATC = « **A10BK** »)

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] un dépistage biologique du diabète par un dosage de la glycémie à jeun depuis 3 ans ou moins.* » :

- Dosage de la glycémie à jeun (code NABM = « **0552** ») dans les 36 derniers mois

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patient « médecin traitant » de 45 ans et plus atteint de maladie cardiovasculaire ou associée au 31/12 de l'année N (à l'exclusion des patients diabétiques), le médecin est rémunéré si le patient a bénéficié d'un dépistage biologique du diabète par un dosage de la glycémie à jeun entre le 01/01 de l'année N-2 et le 31/12 de l'année N.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre le dépistage du diabète parmi ses patients éligibles à ce dépistage.

Conformément aux recommandations en vigueur, le dépistage biologique du diabète repose sur le dosage de la glycémie à jeun tous les 3 ans. Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a bénéficié d'un dosage de la glycémie à jeun depuis 3 ans ou moins.

Le ciblage de la population éligible s'appuie sur les recommandations de la HAS. Il s'agit de toutes les personnes de 45 ans et plus à risque de développer un diabète. Cette notion de « risque de développer un diabète » repose sur un groupe de pathologies chroniques désignées sous le terme de maladies cardiovasculaires ou associées (MCVA) incluant, outre le diabète, les antécédents d'accident vasculaire cérébral invalidant, les artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, les troubles du rythme, les cardiopathies vasculaires et congénitales graves, la maladie coronaire, et la maladie rénale chronique.

Les personnes ayant déjà un diabète connu sont exclues de l'indicateur.

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- HAS : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/diabete_rap_2003.pdf
- Société savante : https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/39/4043/7238227

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;

- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Maladie cardio-vasculaire ou associée diagnostiquée mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;

b. Critères d'exclusion

- Diabète diagnostiqué mais :
  - Sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;
    ET
    - Sans traitement médicamenteux ;
      OU
    - Uniquement traité par agonistes du GLP-1 ou inhibiteurs du SGLT2 ;
      OU
    - Médicaments délivrés par la pharmacie interne dans le cadre d'un séjour en établissement ;

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Dosage de la glycémie à jeun réalisé dans le cadre d'un séjour en établissement.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : aucune profondeur (âge et ALD actives uniquement)
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : 12 mois pour les médicaments
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 36 mois
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 120 mois

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- × PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie